

Mapowanie *zachowań BDD*

Przed pracą nad zachowaniami trzeba je zobaczyć. Karta pomaga zinwentaryzować: co robisz, jak często, ile czasu zajmuje, jaki dystres obniża. Bez tej mapy ERP błądzi po omacku.

CZAS: 30 min — mapowanie Przed drabiną ekspozycji

ŹRÓDŁO: Wilhelm, Phillips & Steketee (2013); Veale (2004)

JAK UŻYWAĆ

Zachowania bezpieczeństwa w BDD to wszystko, co robisz w odpowiedzi na lęk o wygląd: sprawdzanie w lustrze, kamuflaż, pytanie o zapewnienie, unikanie, mentalne porównania, skubanie skóry, mierzenie. Każde z nich *chwilowo obniża* dystres — i *długoterminowo wzmacnia* BDD. Mózg uczy się: „*tylko te zachowania chronią*”. Bez ich mapowania ERP (terapia ekspozycji + zapobieganie reakcji) nie ma w co celować. **Sześć kategorii** do zinwentaryzowania: **1) sprawdzanie, 2) kamuflaż, 3) pytanie o zapewnienie, 4) mentalne porównywanie, 5) modyfikacja ciała** (skubanie, mierzenie, dieta, trening), **6) unikanie**. Cel: wypełniona mapa z konkretnymi — *co, jak często, ile czasu, jaki dystres obniża*.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Wilhelm i Steketee (2013) w protokole CBT-BDD **pierwsze 2-3 sesje** poświęcają mapowaniu. Bez tego pacjent i terapeuta pracują na ogólnikach („*za dużo sprawdzam*”) — nie wiedząc, ile dokładnie razy, w jakich sytuacjach, jak długo. Mapa jest *diagnostyczna*: pokazuje, gdzie BDD jest najsilniejsze. Veale (2004) opisał, że **średnia osoba z umiarkowanym BDD** wykonuje 50-200 zachowań bezpieczeństwa dziennie — większość pozaświadomie. Sprawdzenie w odbiciu witryny sklepowej trwa 2 sekundy — przez dzień to 30-60 sekund kumulatywnie, ale *setki mikrowzmocnień*. Dopiero kiedy pacjent *zobaczy ich liczbę*, motywacja do pracy wzrasta. Mapa *jest też* bazą do drabiny ekspozycji: które zachowania wycofać najpierw, które będą najtrudniejsze. Bez mapy ERP błądzi.

01 = Sześć kategorii zachowań BDD

1 · SPRAWDZANIE

Lustro, odbicia (witryny, telefon, tyłka), zdjęcia własne, dotykanie „defektu”, mierzenie taśmą / linijką, ważenie się.

2 · KAMUFLAŻ

Makijaż (warstwy korektora, podkład), ubrania zakrywające, fryzura zasłaniająca, okulary, czapka, kaptur, biżuteria odciągająca uwagę.

3 · PYTANIE O ZAPEWNIENIE

„Czy widać?”, „Wyglądam dobrze?”, „Czy ten makijaż zakrywa?”. Partner, mama, przyjaciel, czasem nieznajomi (chirurg, dermatolog).

4 · MENTALNE PORÓWNYWANIE

Patrzenie na innych na ulicy, w mediach, w pracy. Mentalna „punktacja” siebie vs nich. Wracanie pamięcią do zdjęć siebie sprzed.

5 · MODYFIKACJA CIAŁA

Skubanie skóry, włosów, paznokci. Kompulsywny trening. Restrykcyjna dieta. Sterydy. Suplementy. Konsultacje u chirurgów, dermatologów.

6 · UNIKANIE

Unikanie luster, zdjęć, jasnego światła, plaży, basenu, randek, spotkań, sytuacji wymagających kontaktu wzrokowego.

02 \ Moja mapa — inwentarz zachowań BDD

#	KONKRETNE ZACHOWANIE	CZĘSTOŚĆ x/dzień	CZAS min/dzień	SUDS PRZED 0–10	WYZWALACZ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

03 Trzy zasady dobrego mapowania

1. Bez oceny. Mapowanie ma być *opisem*, nie potępieniem. Nie pisz „znowu sprawdziłem, jak idiota” — pisz „sprawdzenie w lustrze, 30 sek, SUDS 6”. Bez oceny = łatwiej zobaczyć dane.

2. Konkretność. Nie „sprawdzanie”, lecz „sprawdzanie w lustrze w łazience, rano po prysznicu, 5–10 min”. Im konkretniej, tym lepsza baza do ekspozycji.

3. Tydzień obserwacji. Mapuj 7 dni — różne sytuacje, dni tygodnia, nastroje. Po tygodniu masz *realny* obraz. Po jednym dniu masz tylko fragment.

Klucz: Wilhelm (2013): „pacjenci często są zaskoczeni, gdy widzą swoją mapę. Liczba zachowań — 50, 100, 200 dziennie — jest często szokująca. Ale to nie wstyd. To diagnoza. Mapa pokazuje, ile pracy mózg robi codziennie, by chronić się przed wyimaginowanym zagrożeniem. ERP uczy mózg, że ochrona nie jest potrzebna”. Mapa nie jest karą — jest pierwszym narzędziem zmiany.